IMSS

Dirección de Prestaciones Médicas

Coordinación de Proyectos Especiales en Salud

Guía Operativa para el Diseño y Ejecución de Simulacros de Gabinete y Simulacros de Campo en Establecimientos de Salud del IMSS

ÍNDICE

Directorio 4
1. Objetivos, alcance y definiciones 6
2. Principios generales de actuación 8
3. Procedimiento técnico y operativo para el diseño y ejecución de simulacros de gabinete y simulacros de campo 9
3.1 Aspectos clave en cada fase 9
3.1.1 Acciones durante la fase de planificación y diseño 9
3.1.2 Actividades en la fase de ejecución y control 10
3.1.3 Fase de recapitulación, evaluación y mejora 11
3.2 Procedimiento operativo para ejercicios de escritorio 11
Paso 1. Definición rápida del ejercicio 11
Paso 2. Conformación del Equipo de Gestión del Ejercicio 11
Paso 3. Diseño del guion del ejercicio de escritorio 11
Paso 4. Preparación logística 12
Paso 5. Ejecución del ejercicio de escritorio 12
Paso 6. Evaluación y plan de mejora 12
3.3 Procedimiento operativo para simulacros de campo (ejercicios funcionales / de despliegue) 12
Paso 1. Definición del simulacro de campo 13
Paso 2. Análisis de riesgos y seguridad 13
Paso 3. Diseño técnico del simulacro de campo 13
Paso 4. Preparación logística y comunicación previa 13
Paso 5. Ejecución del simulacro de campo 14
Paso 6. Recapitulación, evaluación y mejora 14
4. Anexos 15
Anexo 1. Diagrama de flujo del proceso de diseño y ejecución de ejercicios 15
Anexo 2. Lista de verificación para la planificación de ejercicios de escritorio 16
Anexo 3. Lista de verificación para la planificación de simulacros 18
Anexo 4. Modelo de ficha técnica del ejercicio 20

Anexo 5. Modelo de informe posterior al ejercicio 21
Anexo 6. Modelo de plan de mejora derivado del ejercicio (ejemplo) 23
Referencias 24
Recursos 24
Contacto 25

Directorio

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto
Dirección General

Dr. Jorge Gaviño Ambriz
Secretaría General

Dra. Alva Alejandra Santos Carrillo
Dirección de Prestaciones Médicas

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Mtro. Borsalino González Andrade
Dirección de Administración

Lic. Luisa Obrador Garrido Cuesta
Dirección de Incorporación y Recaudación

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Dirección Jurídica

Mtra. Claudia Laura Vázquez Espinoza
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo
Dirección de Finanzas

Lic. Javier Guerrero García
Dirección de Operación y Evaluación

Mtro. Arturo De Lucio Ortega
Dirección de Planeación para la Transformación Institucional

Dra. Janett Alvarado González
Coordinación de Proyectos Especiales en Salud

Este documento fue elaborado por la **Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS,** atiende las recomendaciones de los ítems 64, 66,123, 147, 148 del Índice de Seguridad Hospitalaria de la Organización Panamericana de la Salud e incorpora recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y mejores prácticas basadas en la evidencia sobre Diseño y Ejecución de Ejercicios de Simulacros de Gabinete y Simulacros de Campo.

Es responsabilidad de cada establecimiento de salud adaptar las recomendaciones aquí vertidas, considerando sus capacidades, recursos, nivel de atención, análisis de riesgos y condiciones particulares, bajo el criterio técnico y profesional del personal responsable, priorizando la seguridad de pacientes, personal y la continuidad de los servicios.

Derechos reservados © 2026

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos patrimoniales.

1. Objetivos, alcance y definiciones

Objetivo General

Establecer el procedimiento técnico y operativo estándar para que los establecimientos de salud del IMSS, en todos sus niveles de atención, diseñen, planifiquen, ejecuten y evalúen ejercicios de simulacro de gabinete y simulacros de campo orientados a poner a prueba el Plan Hospitalario de Respuesta ante Emergencias y Desastres (PH-RED), fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de respuesta antes, durante y después de estos eventos adversos.

Objetivos Específicos

1. Proporcionar lineamientos prácticos para la planificación, diseño, realización y evaluación de ejercicios de simulacros de gabinete y simulacros de campo en establecimientos de salud del IMSS.
2. Promover la armonización con el Plan Hospitalario de Respuesta ante Emergencias y Desastres, el Programa Interno de Protección Civil y con los programas institucionales de preparación y respuesta.
3. Favorecer un enfoque de mejora continua, basado en lecciones aprendidas y planes de mejora derivados de cada ejercicio.

Ámbito de aplicación

Aplica a todos los establecimientos de salud del IMSS de primero, segundo y tercer nivel, incluidos hospitales, unidades médicas de alta especialidad, unidades de medicina familiar con servicios de urgencias y unidades complementarias.

Se articula con el Plan Institucional Frente a Emergencias y Desastres (PIFED), el Programa Interno de Protección Civil y los Planes específicos o de contingencia. Los resultados de los ejercicios desarrollados conforme a esta guía deberán documentarse y utilizarse para la toma de decisiones, la actualización de planes y la programación de acciones de mejora institucional.

Alcance

El presente documento está dirigido al personal directivo y a los integrantes del Comité de Emergencias y Desastres de los Establecimientos de Salud, personas responsables de áreas críticas (urgencias, terapia intensiva, quirófanos, hospitalización, laboratorio, imagenología, etc.), quienes participan en el desarrollo de implementación de Planes de Respuesta, incluidos aquellos que forman parte de los equipos de gestión del ejercicio.

Definiciones clave:

- **Planes de Simulacro:** es una metodología planificada que recrea escenarios clínicos, de emergencia o desastre (de forma controlada o mediante prácticas realistas) con el propósito de capacitar al personal, evaluar procedimientos, verificar capacidades técnicas

y operativas, así como fortalecer la preparación y respuesta de los establecimientos de salud ante situaciones adversas.

- **Ejercicio de Simulacro de gabinete:** Conjunto de actividades en la que los participantes plantean decisiones y acciones teóricas frente a un escenario hipotético, con el objetivo de evaluar la capacidad de análisis, toma de decisiones, coordinación y comunicación de las personas responsables.
- **Ejercicio de Simulacro de Campo:** Conjunto de actividades para dar una respuesta real ante una emergencia, en la que sí se movilizan personas, equipos y procedimientos, aunque la situación sea ficticia, con el objetivo de practicar el procedimiento real de respuesta ante una emergencia.
- **Desastre:** Disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debida a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando pérdidas o impactos humanos, materiales, y ambientales.
- **Emergencia:** Evento o amenaza que produce o tiene potencial de producir una variedad de consecuencias que requieren una acción urgente y coordinada.
- **Emergencia Mayor:** Una situación que afecta gravemente la salud de una población y cuya magnitud, gravedad o rapidez de evolución supera la capacidad de respuesta habitual de los servicios de salud, requiriendo la movilización extraordinaria de recursos, la activación de mecanismos especiales de coordinación y la adopción de medidas inmediatas para controlar sus efectos.
- **Plan Hospitalario de Respuesta ante Emergencias y Desastres (PH-RED)**: Conjunto de acciones y actividades encaminadas a preparar a los establecimientos de salud para prevenir, enfrentar y mitigar eventos que amenacen o que produzcan disrupción grave en el funcionamiento y salud pública.
- **Equipo de Gestión del Ejercicio**: Grupo multidisciplinario responsable de la elaboración de los ejercicios de Simulacros de gabinete y Simulacros de Campo para la puesta a prueba de los Planes de Atención para Emergencias Mayores y Desastres de los establecimientos de salud.
- **Director del ejercicio:** Encargado de la coordinación general de la planificación, la realización y la evaluación del ejercicio. Es responsable de la aprobación de los objetivos y del alcance del ejercicio.
- **Evaluador:** persona que recoge datos del ejercicio y, analiza el cumplimiento de los objetivos y las metas del ejercicio. La evaluación incluye el desempeño general, la respuesta operativa, las capacidades, las buenas prácticas y las áreas de oportunidad para la mejora de los planes de respuesta y disminuir las repercusiones.

- **Facilitador del ejercicio:** persona responsable de entregar mensajes y vigilar el progreso durante un ejercicio. El facilitador es el primer punto de contacto para toda pregunta o aclaración o solicitud.
- **Participante:** persona que en el ejercicio simula una función específica otorgada previamente a la realización de este.

2. Principios generales de actuación

1. **Seguridad del personal y de los pacientes.** Ningún ejercicio justificará acciones que pongan en riesgo la integridad de pacientes, personal o visitantes. Las actividades de simulacro deberán coordinarse con protección civil y seguir las normas de seguridad vigentes.
2. **Alineación con los planes institucionales.** Todo ejercicio deberá estar vinculado al Plan Hospitalario de Respuesta ante Emergencias y Desastres, al Programa Interno de Protección Civil y a los planes específicos (por ejemplo, QBRNE, brotes epidémicos, incendio, falla de servicios críticos).
3. **Enfoque programático y modular.** Los ejercicios formarán parte de un programa anual de simulacros, que considere diferentes tipos de ejercicios (simulacros de escritorio y simulacros de campo) en función de las prioridades del establecimiento y de los riesgos identificados.
4. **Mejora continua.** Cada ejercicio debe generar recomendaciones concretas y un plan de mejora que retroalimente los planes y procedimientos, en coherencia con el enfoque de "planificación–ejecución–evaluación–ajuste" promovido por el Manual de la OMS para ejercicios de simulacros.
5. **No punitivo.** Los ejercicios no tienen como objetivo sancionar al personal, sino fortalecer procesos y capacidades institucionales; la evaluación se centra en el sistema, no en la persona.
6. **Participación multidisciplinaria.** Deben involucrarse direcciones, mandos intermedios, personal operativo y, cuando aplique, enlaces con otros establecimientos, servicios prehospitalarios y autoridades externas.
7. **Enfoque en grupos en situación de vulnerabilidad.** Al diseñar escenarios y flujos, considerar desde el inicio a niñas y niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con discapacidad o barreras de comunicación y movilidad. La planificación de simulacros deberá incorporar de manera transversal la variable discapacidad, considerando las barreras físicas, comunicacionales, organizacionales y

actitudinales que pueden afectar la respuesta ante emergencias, garantizando ajustes razonables, participación significativa y un enfoque de derechos humanos.

8. **Comunicación clara y oportuna.** Utilizar mensajes sencillos, canales de comunicación definidos y un vocero institucional para comunicar objetivos del ejercicio, alcances y posibles impactos en la operación rutinaria.

3. Procedimiento técnico y operativo para el diseño y ejecución de simulacros de gabinete y simulacros de campo

El procedimiento se organiza en tres fases operativas:

- Antes del ejercicio: planificación, diseño técnico y preparación.
- Durante el ejercicio: conducción y control del ejercicio de gabinete o del simulacro de campo.
- Después del ejercicio: recapitulación, evaluación y plan de mejora.

3.1 Aspectos clave en cada fase

3.1.1 Acciones durante la fase de planificación y diseño

1. Constituir el Equipo de Gestión del Ejercicio (Director, facilitadores, evaluadores, apoyo logístico).
2. Definir objetivos del ejercicio respondiendo:
   - ¿Qué procesos o capacidades queremos probar (triage, evacuación, SCI-H, comunicación, continuidad operativa, etc.)?
   - ¿Cuáles son las prioridades institucionales y riesgos críticos identificados?
3. Definir alcance:
   - Definir la hipótesis con base en amenazas identificadas o eventos ocurridos (saldo masivo de víctimas, sismos, QBRNE, brote epidémico, interrupción de servicios críticos, etc.).
   - Áreas y servicios involucrados, incluyendo sus roles participantes y funciones.
   - Elementos que no estarán incluidos (por ejemplo, no movilizar pacientes críticos reales).
4. Seleccionar el tipo de ejercicio:
   - Ejercicio de escritorio (simulacro de gabinete).
   - Simulacro de campo o de despliegue (con movilización de recursos).
5. Elaborar cronograma:

- Planificación y elaboración: recomendable de 2 a 3 meses.
- Ejecución: 1 día.
- Evaluación, informe y plan de mejora: hasta 15 días posterior al ejercicio.

6. Diseñar el escenario y el guion (minuto a minuto):
   - Describir el evento inicial, evolución, hitos de decisión y mensajes para los participantes (Fecha y hora del ejercicio, Identificación del tipo de amenaza o riesgo, Lugar y área de afectación, Duración del ejercicio, Identificación y preparación de áreas, rutas de evacuación y puntos de encuentro).
   - Preparar línea de tiempo del ejercicio y matriz de mensajes: Describir la secuencia de eventos y tiempos de desarrollo para dirigir a los participantes a través de los simulacros de gabinete.
7. Definir recursos y logística:
   - Espacios físicos, equipos, insumos, sistemas de comunicación, material de caracterización, etc.
   - Coordinar con las áreas y servicios al interior del establecimiento, y con otras unidades, organizaciones, agencias de seguridad, protección civil, al exterior.
   - Contemplar el personal requerido, los recursos financieros, espacios, equipos y materiales además de vehículos.
8. Capacitación
   - Sobre los roles que el personal desempeñara durante el ejercicio
9. Diseñar herramientas de evaluación:
   - Listas de verificación, formatos de observación, encuestas de satisfacción, matrices de indicadores.

3.1.2 Actividades en la fase de ejecución y control

1. Realizar reunión de orientación con directivos, Comité de Emergencias, participantes, facilitadores y evaluadores: presentar objetivos, alcance, reglas, medidas de seguridad y cronograma (minuto a minuto).
2. Confirmar canales de comunicación interna y externa.
3. Ejecutar el ejercicio conforme al guion:
   - El facilitador emite los mensajes.
   - Los participantes responden según sus roles del Plan Hospitalario.
   - Los evaluadores registran hallazgos sin intervenir en las decisiones.
4. Mantener control de seguridad y, en caso de emergencias reales, suspender el ejercicio y activar los planes reales.
5. Cerrar el ejercicio con un mensaje formal de terminación.

3.1.3 Fase de recapitulación, evaluación y mejora

1. Realizar sesión de recapitulación inmediata (debriefing) con participantes y evaluadores por área.
2. Consolidar la información de las herramientas de evaluación.
3. Elaborar el informe final del ejercicio, que incluya:
   - Descripción del ejercicio.
   - Cumplimiento de objetivos.
   - Principales fortalezas y buenas prácticas.
   - Principales brechas y problemas críticos.
   - Recomendaciones y plan de mejora con responsables y plazos.
4. Socializar resultados con la dirección del establecimiento, el Comité de Emergencias y los niveles de mando correspondientes (OOAD, nivel central), y programar el siguiente ejercicio para evaluar las mejoras implementadas.

3.2 Procedimiento operativo para ejercicios de escritorio

Objetivo: validar procedimientos, roles y toma de decisiones del Plan Hospitalario de Respuesta ante un escenario específico, sin despliegue físico de recursos.

Paso 1. Definición rápida del ejercicio

- Tipo: ejercicio de escritorio o gabinete.
- Tema principal (ej.: arribo masivo de víctimas, sismo, falla prolongada de energía, brote epidémico, incidente QBRNE).
- Objetivo(s) específico(s) y alcance.

Paso 2. Conformación del Equipo de Gestión del Ejercicio

- Director del ejercicio.
- 1–2 facilitadores.
- 2–4 evaluadores, según número de mesas de trabajo.
- Apoyo logístico (TI, papelería, sala, proyección).

Paso 3. Diseño del guion del ejercicio de escritorio

Elementos mínimos:

1. Escenario base (1–2 páginas): descripción de la unidad, contexto del evento, situación inicial.
2. Inyectores o mensajes (matriz de mensajes):
   - Tiempo (ej. minuto 0, minuto 15, minuto 30).

- Mensaje para los participantes (ej. reporte de incremento de pacientes, falla de sistema, falta de insumos).
- Preguntas guía ("¿qué acciones toman?", "¿a quién informan?", "¿cómo organizan el SCI-H?").

3. Productos esperados: decisión tomada, activación de códigos, uso de formatos, flujos de referencia, etc.

Paso 4. Preparación logística

- Reservar sala(s), medios audiovisuales, pizarrones / rotafolios.
- Distribuir a los participantes por funciones del plan (sala de crisis, coordinación de operaciones, logística, etc.).
- Entregar antes del ejercicio:
    - Plan Hospitalario de Respuesta.
    - Organigrama del SCI-H.
    - Mapas del hospital y de la red de referencia.

Paso 5. Ejecución del ejercicio de escritorio

1. Reunión de apertura (10–15 minutos): objetivos, reglas, tiempos.
2. Desarrollo del ejercicio (60–120 minutos):
    - El facilitador presenta el escenario inicial y cada mensaje.
    - Los equipos discuten y definen sus decisiones.
    - Los evaluadores observan, registran tiempos y decisiones clave.
3. Cierre y recapitulación (30–45 minutos):
    - Cada equipo presenta sus decisiones.
    - El facilitador resume hallazgos y se identifican brechas y buenas prácticas.

Paso 6. Evaluación y plan de mejora

- Completar listas de verificación y fichas de evaluación.
- Elaborar informe sintético (máx. 5 páginas) con hallazgos clave y propuestas de mejora.

3.3 Procedimiento operativo para simulacros de campo (ejercicios funcionales / de despliegue)

Objetivo: poner a prueba, en condiciones controladas, la respuesta operativa real del establecimiento (movilización de personal, uso de recursos, flujos de pacientes y coordinación con otros actores).

Paso 1. Definición del simulacro de campo

- Tipo de evento (ej.: evacuación por incendio, arribo masivo de víctimas, sismo, fuga de sustancias peligrosas, falla prolongada de energía, etc.).
- Objetivos específicos (ej.: validar evacuación segura de áreas críticas, probar SCI-H, probar comunicación con CVOED, etc.).

Paso 2. Análisis de riesgos y seguridad

- Evaluar posibles riesgos para pacientes y personal.
- Definir medidas de mitigación (no movilizar pacientes críticos reales, rutas seguras, uso de señalización, personal de apoyo).
- Coordinar el simulacro con protección civil, seguridad interna, bomberos y servicios prehospitalarios.

Paso 3. Diseño técnico del simulacro de campo

Incluye, como mínimo:

1. Guion general del ejercicio (minuto a minuto):
   - Condiciones iniciales (operación normal, ocupación de camas, estado de servicios críticos).
   - Secuencia cronológica de eventos (minuto 0: alerta, minuto 10: llegada de primeras víctimas, minuto 20: saturación de urgencias, etc.).
2. Mapa de áreas y rutas:
   - Zonas de impacto, rutas de evacuación, puntos de reunión, áreas de expansión, etc.
3. Roles y responsabilidades:
   - Comandante del incidente, sección de operaciones, logística, finanzas, seguridad, comunicación, responsables de triage, binomios de atención, etc.
4. Recursos de simulación:
   - Figurantes/pacientes simulados, tarjetas de víctimas, material para caracterización, ambulancias, equipos médicos, entre otros.

Paso 4. Preparación logística y comunicación previa

- Elaborar y distribuir la ficha técnica del simulacro de campo (fecha, horario, objetivos, áreas involucradas, responsables).
- Informar a todo el personal sobre la realización del simulacro de campo, diferenciando claramente la situación simulada de una emergencia real.
- Informar, cuando proceda, a la comunidad usuaria y a autoridades locales para evitar alarma injustificada.

Paso 5. Ejecución del simulacro de campo

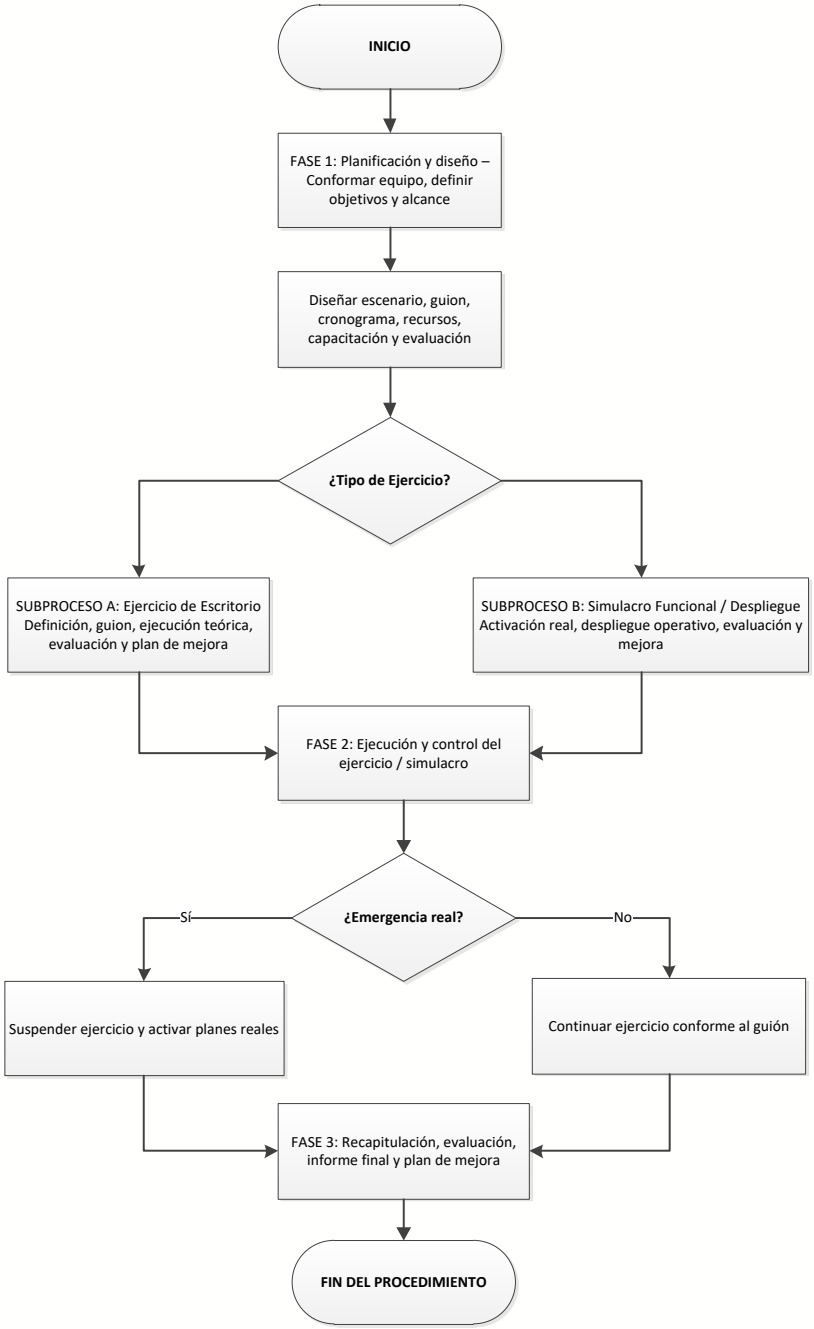
1. Activación:
   - Emisión de la alerta simulada y activación del Plan Hospitalario de Respuesta (código institucional correspondiente).
2. Despliegue de la respuesta:
   - Movilización del SCI-H y de las áreas de atención.
   - Ejecución de acciones reales (evacuación, triage, clasificación y atención de víctimas, referencia, etc.).
3. Observación y registro:
   - Evaluadores en puntos estratégicos documentan tiempos, decisiones, flujos de comunicación y uso de recursos.
4. Cierre del simulacro de campo:
   - Mensaje claro de finalización y retorno a la operación normal.

Paso 6. Recapitulación, evaluación y mejora

- Realizar debriefing inmediato por servicios/áreas.
- Completar formatos de evaluación y consolidar el informe final.
- Elaborar y dar seguimiento al plan de mejora y programar un nuevo simulacro de campo para validar las correcciones implementadas.

4. Anexos

Anexo 1. Diagrama de flujo del proceso de diseño y ejecución de ejercicios



Anexo 2. Lista de verificación para la planificación de ejercicios de escritorio

Actividad	Realizado	En proceso	No realizado
1. Definición de objetivos del ejercicio			
1.1 Se ha definido la finalidad general del ejercicio (¿para qué se realiza?).			
1.2 Se han formulado objetivos específicos claros, medibles y alcanzables.			
1.3 Los objetivos están alineados con el Plan Hospitalario de Respuesta ante Emergencias y Desastres y el Programa Interno de Protección Civil del establecimiento.			
1.4 Se han identificado las funciones o capacidades que se desean probar (comando, triage, referencia, comunicación, continuidad operativa, etc.).			
2. Definición del alcance			
2.1 Se ha determinado el tipo de evento/escenario (sismo, arribo masivo de víctimas, falla de energía, emergencia QBRNE, brote epidémico, etc.).			
2.2 Se han definido las áreas y servicios del hospital que participarán (urgencias, hospitalización, UCI, quirófanos, laboratorio, imagen, farmacia, etc.).			
2.3 Se ha especificado el nivel de complejidad del ejercicio (básico, intermedio, avanzado).			
2.4 Se ha establecido la duración estimada del ejercicio (planeación, desarrollo y reunión de evaluación).			
2.5 Se han identificado los límites del ejercicio (qué sí y qué no se va a simular).			
3. Equipo de gestión del ejercicio			
3.1 Se ha nombrado un Director del ejercicio.			
3.2 Se han designado facilitador(es) responsables de conducir el escenario y los mensajes.			
3.3 Se han designado evaluadores/observadores, con áreas específicas de observación.			
3.4 Se ha asignado personal para apoyo logístico y de TI (sala, equipo audiovisual, impresión de materiales).			
3.5 Se han definido claramente las atribuciones y responsabilidades de cada integrante del equipo de gestión.			
4. Participantes			
4.1 Se ha elaborado una lista de participantes por nombre, cargo y servicio.			
4.2 Los participantes representan los roles clave del Plan Hospitalario (dirección, SCI-H, jefes de servicio, enlaces con otras instituciones, etc.).			
4.3 Se ha enviado invitación formal o comunicación interna con la información básica del ejercicio (fecha, hora, lugar, objetivos).			
4.4 Se ha verificado que los participantes conocen previamente sus funciones reales en caso de emergencia (formación previa mínima).			
5. Recursos y logística			
5.1 Se ha definido y reservado la sala o salas para el ejercicio (salón de crisis, salas por servicio, etc.).			
5.2 Se cuenta con equipos audiovisuales suficientes (proyector, pantalla, computadora, sonido).			
5.3 Se han preparado materiales impresos o digitales (Plan Hospitalario de Respuesta, organigrama del SCI-H, mapas y planos del hospital).			
5.4 Se dispone de papelería básica (hojas, plumones, rotafolios, notas adhesivas).			
5.5 Se cuenta con un cronograma detallado del ejercicio (agenda con horas y responsables).			
6. Diseño del guion y del escenario			

6.1 Se ha elaborado una nota conceptual o resumen del ejercicio (finalidad, objetivos, alcance, tipo de ejercicio, actores clave).			
6.2 Se ha definido un escenario base que describa la situación inicial del hospital y del evento (operación habitual, ocupación de camas, servicios críticos, contexto externo).			
6.3 Se ha preparado una secuencia de eventos con tiempos (línea de tiempo del ejercicio).			
6.4 Se ha elaborado una matriz de mensajes/inyecciones (momento, contenido del mensaje, actor que lo emite, respuesta o decisión esperada).			
6.5 El guion integra explícitamente las decisiones críticas que se desean observar (activación del plan, organización del SCI-H, referencia/contrarreferencia, comunicación interna y externa, etc.).			
6.6 Todos los documentos del ejercicio están claramente marcados como “SOLO PARA EL SIMULACRO”.			
7. Herramientas de evaluación			
7.1 Se han definido desde la planificación las categorías de evaluación, alineadas con los objetivos del ejercicio (comando, coordinación, comunicación, logística, continuidad operativa, etc.).			
7.2 Se ha identificado la cantidad necesaria de evaluadores y las áreas que observará cada uno.			
7.3 Se han elaborado instrumentos de evaluación (listas de verificación por función o área, formatos de observación, formularios de sugerencias para participantes).			
7.4 Se ha decidido si se utilizarán medios de apoyo (grabaciones de audio y/o video) para complementar la evaluación.			
7.5 Se han identificado, si es necesario, instituciones o personas expertas externas que apoyarán en la evaluación.			
8. Aspectos administrativos, comunicaciones y seguridad			
8.1 Se ha revisado una lista de verificación administrativa y logística (permisos internos, oficios, uso de espacios, TI, etc.).			
8.2 Se ha definido el plan de comunicaciones internas para avisar sobre la realización del ejercicio (sin confundirlo con una emergencia real).			
8.3 Se ha designado un punto focal de seguridad del ejercicio, aunque sea teórico, para gestionar cualquier incidente real durante la actividad.			
8.4 Se ha previsto un mecanismo para suspender el ejercicio si se presenta una emergencia real que requiera la activación del plan hospitalario.			
9. Enfoque de discapacidad e inclusión			
El ejercicio incorporó la variable discapacidad desde el diseño del escenario.			
Se analizaron barreras organizacionales y de decisión, no solo operativas.			
Se evaluó la aplicación de ajustes razonables en la toma de decisiones.			
Se documentaron aprendizajes específicos relacionados con discapacidad.			
Se generaron acciones de mejora institucional vinculadas al plan de emergencias			

Anexo 3. Lista de verificación para la planificación de simulacros

Actividad	Realizado	En proceso	No realizado
1. Evaluación inicial			
Se ha identificado la necesidad del ejercicio (evaluaciones previas, lecciones aprendidas, cambios en planes/procedimientos).			
Se han obtenido aprobaciones de la alta dirección y asignación de recursos (humanos, financieros, logísticos).			
Se ha realizado un análisis de riesgos para seleccionar el escenario y tipo de ejercicio.			
2. Equipo y gobernanza			
Se ha constituido el equipo de planificación del ejercicio, con roles claramente definidos (coordinador, logística, comunicaciones, evaluadores).			
Se ha definido un encargado general del ejercicio			
Se han identificado participantes, observadores e invitados relevantes.			
Los roles de cada participante están documentados y comprendidos.			
3. Propósito, alcance y objetivos			
Se ha establecido el propósito general del ejercicio.			
Se han definido objetivos específicos, medibles y alineados con el propósito institucional.			
El alcance del ejercicio está claramente delimitado (qué se prueba y qué no).			
4. Escenario y formato			
Se ha seleccionado o diseñado un **escenario realista y relevante** para la institución.			
El tipo de ejercicio (simulacro de gabinete, operativo, funcional o a escala real) está definido.			
Se ha elaborado un guion del simulacro minuto a minuto (si aplica).			
5. Planificación y cronograma			
Se ha elaborado un cronograma de planificación con hitos clave.			
Se han programado reuniones de planificación y ensayos previos.			
Las fechas y horas del ejercicio están confirmadas y comunicadas a todos los involucrados.			
6. Infraestructura y logística			
Se ha definido y reservado el **lugar (físico o virtual)** donde se llevará a cabo el ejercicio.			
Se han previsto **recursos logísticos** (equipos, materiales, comunicaciones, transporte).			
Se han identificado y mitigado riesgos logísticos y de seguridad relacionados con el ejercicio.			
7. Comunicación			
Existe un plan de comunicación interna claro para los participantes.			
Se han previsto mensajes oficiales y procedimientos para la comunicación pública (si aplica).			

Se han definido palabras clave o señales para identificar acciones del ejercicio frente a situaciones reales.			
8. Documentación			
Se han desarrollado y difundido todos los documentos base del ejercicio (nota conceptual, plan de ejercicio, guiones, instrucciones de jugadores).			
Se han preparado instrumentos de evaluación (listas de verificación, indicadores, formularios de observación).			
Se ha definido un registro de riesgos específicos del ejercicio con planes de mitigación.			
9. Capacitación y preparación			
Los participantes han recibido orientación previa sobre el ejercicio y sus roles.			
Se ha proporcionado formación o actualización en procedimientos relevantes.			
Se ha realizado un ensayo general o sesión de prueba (si aplica).			
10. Evaluación y seguimiento			
Se ha definido cómo se evaluará el ejercicio frente a los objetivos planteados (criterios, indicadores).			
Se ha planificado una reunión de evaluación posterior.			
Se ha establecido un plan para incorporar lecciones aprendidas en los procedimientos o sistemas institucionales.			
11. Inclusión de personas con discapacidad			
La planificación del simulacro incorporó el enfoque de discapacidad desde el diseño.			
Se identificaron personas con discapacidad en población usuaria, trabajadora o visitante.			
Se evaluaron barreras físicas, comunicacionales y organizacionales.			
Se aplicaron ajustes razonables durante el ejercicio.			
Se documentaron aprendizajes específicos sobre discapacidad.			
Las mejoras derivadas se integrarán a planes, protocolos y capacitación.			
11. Opcionales según contexto			
Se han asignado evaluadores externos o pares para aportar una perspectiva imparcial.			
Se han considerado intercambios interinstitucionales (participación de otras entidades relevantes).			
Se ha planificado una comunicación de resultados pública (informes, lecciones aprendidas).			

Anexo 4. Modelo de ficha técnica del ejercicio

Campo	Información del ejercicio
Establecimiento de salud	Nombre de la unidad
Nivel de atención	☐ 1er nivel ☐ 2do nivel ☐ 3er nivel
Ubicación	Entidad federativa / municipio / OOAD
Fecha de realización	
Horario	Hora de inicio - hora de término
Duración estimada	(incluye apertura, desarrollo y debriefing)
Nombre del ejercicio	
Tipo de ejercicio	☐ Simulacros de gabinete ☐ Simulacro de campo (funcional / despliegue)
Tema / amenaza principal	(p. ej. sismo, arribo masivo de víctimas, falla eléctrica, emergencia QBRN, brote, etc.)
Objetivo general	
Objetivos específicos	1) 2) 3)
Alcance	Áreas y servicios involucrados; procesos a probar
Número estimado de participantes	Total y por perfil (directivos, mandos intermedios, personal operativo, otros)
Director(a) del ejercicio	Nombre, cargo y servicio
Equipo de facilitación	Nombres y cargos de facilitadores
Equipo de evaluación / observación	Nombres y cargos de evaluadores
Apoyo logístico y de TI	Responsables (sala, mobiliario, TI, papelería, etc.)
Escenario base	Resumen de la situación inicial (1–3 líneas)
Hipótesis del ejercicio	Supuestos clave (p. ej. “no se movilizan pacientes críticos”, “se simula falla total”)
Limitaciones del ejercicio	Lo que explícitamente no se evalúa ni se simula
Productos esperados	Decisiones, flujos, formatos, activaciones que se espera observar
Documentos de referencia	Plan hospitalario, programa interno de PC, protocolos específicos, otros
Consideraciones de seguridad	Medidas para evitar riesgos a pacientes, personal y visitantes
Comunicación institucional previa	Cómo se informará al personal y, en su caso, a usuarios / autoridades externas
Autorizaciones	Director(a) del hospital, Comité de Emergencias, otras instancias

Anexo 5. Modelo de informe posterior al ejercicio

Campo	Información del ejercicio
Nombre del ejercicio	
Código / Clave interna	
Tipo de ejercicio	☐ Simulacros de gabinete ☐ Simulacro de campo (funcional / despliegue)
Escenario simulado:	(p. ej. sismo, arribo masivo de víctimas, falla eléctrica, emergencia QBRN, brote, etc.)
Fecha y horario:	
Lugar:	Entidad federativa / municipio / OOAD
Establecimiento de salud:	Nombre de la unidad
Nivel del ejercicio:	☐ Local ☐ Hospitalario ☐ Interinstitucional
Responsable del ejercicio:	
Responsable del informe:	
Antecedentes y justificación:	Motivo de la realización del ejercicio, relación del ejercicio con el Plan de Respuesta a Emergencias y Desastres
Objetivo general:	
Objetivos específicos:	1) 2) 3)
Alcance y limitaciones del ejercicio:	Áreas, servicios y funciones evaluadas, actores participantes, procesos incluidos y excluidos deliberadamente, supuestos utilizados durante el ejercicio, limitaciones identificadas (logísticas, de tiempo, de alcance).
Resumen del escenario:	Situación inicial, evolución del evento simulado, principales hitos del ejercicio.
Cronología resumida:	Tabla o descripción secuencial de eventos relevantes, decisiones clave e inyecciones principales.
Metodología de evaluación:	Enfoque de evaluación utilizado (observación estructurada, listas de verificación, análisis de decisiones), número y perfil de evaluadores, herramientas aplicadas, criterios de análisis alineados con los objetivos del ejercicio.
Resultados por función/capacidad evaluada:	Para cada función evaluada, por ejemplo: 1) Comando y control: Hallazgos principales, fortalezas identificadas, brechas u oportunidades de mejora. (Repetir estructura para cada capacidad evaluada)
Análisis transversal de inclusión y discapacidad:	1) Consideración de la variable discapacidad: ¿El escenario contempló personas con discapacidad (pacientes, personal o visitantes)? ¿La discapacidad influyó en la toma de decisiones estratégicas u operativas?

	2) Identificación de barreras: Barreras organizacionales, barreras comunicacionales, barreras procedimentales. 3) Ajustes razonables aplicados: Qué ajustes se aplicaron, wn qué momento, quién los decidió, impacto en la respuesta. 4) Brechas detectadas: Falta de protocolos, falta de capacitación, falta de claridad en responsabilidades.
Buenas prácticas identificadas:	Enumerar prácticas que: Deben mantenerse, pueden replicarse en otros servicios o establecimientos, representan mejoras respecto a ejercicios previos.
Principales brechas y riesgos identificados:	Presentar de forma clara y priorizada: Brechas críticas, riesgos operativos o estratégicos, riesgos relacionados con derechos, accesibilidad o continuidad operativa.
Recomendaciones y acciones de mejora:	1) Acciones inmediatas (corto plazo) 2) Acciones de mediano plazo 3) Acciones de largo plazo
Conclusiones:	Valoración general del nivel de preparación institucional, grado de cumplimiento de los objetivos del ejercicio, relevancia del ejercicio para el fortalecimiento de la respuesta ante emergencias, necesidad de ejercicios futuros (tipo y enfoque sugerido).
Anexos:	Listas de verificación utilizadas, instrumentos de evaluación, guion y matriz de inyecciones, listado de participantes, materiales utilizados, evidencias documentales (si aplica), plan de mejora

Anexo 6. Modelo de plan de mejora derivado del ejercicio (ejemplo)

No.	Situación identificada	Acción correctiva	Responsable	Plazo	Seguimiento
1	Durante el ejercicio se identificó falta de claridad en los criterios para la activación del Sistema de Comando Hospitalario (SCI-H), lo que generó retrasos en la toma de decisiones iniciales.	Revisar y actualizar el Plan Hospitalario de Respuesta para incorporar criterios operativos claros y escalonados de activación del SCI-H, y difundirlos mediante sesión de capacitación dirigida.	Dirección del Hospital / Jefatura de urgencias /Unidad Interna de Protección Civil	60 días	Verificación documental del plan actualizado y evidencia de capacitación realizada.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Referencias

1. Manual de la OMS para ejercicios de simulación. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2022. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponible en http:/iris.paho.org.
2. Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres en Salud. Manual para simulaciones y simulacros en la gestión del riesgo de emergencias y desastres en salud. Santiago de Chile: Ministerio de Salud; 2021. Disponible en: https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/MANUAL-PARA-SIMULACIONES-Y-SIMULACROS-EN-LA-GESTI%C3%93N-DEL-RIESGO-EMERGENCIAS-Y-DESASTRES-EN-SALUD.pdf
3. Heidaranlu E, Ebadi A, Khankeh HR, Ardalan A. Hospital disaster preparedness tools: a systematic review. PLoS Curr. 2015;7. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4575155/
4. Mahdi SS, Jafri HA, Allana R, et al. Systematic review on the current state of disaster preparation simulation exercises (SimEx). BMC Emerg Med. 2023;23:52. doi:10.1186/s12873-023-00824-8. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1186/s12873-023-00824-8
5. Biswas S, Bahouth H, Solomonov E, Waksman I, Halberthal M, Bala M. Preparedness for mass casualty incidents: the effectiveness of current training model. Disaster Med Public Health Prep. 2022;16(5):2120–2128. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34711298
6. México. Ley General de Protección Civil. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2012; última reforma 21 de diciembre de 2023.

Recursos

Curso: Sistema de Comando de Incidentes para Hospitales (SCI-H). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. Disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/sistema-de-comando-de-incidentes-para-establecimientos de salud.

Curso: Marco de respuesta multiamenaza: Planeamiento hospitalario para la respuesta a emergencias en salud y desastres. Campus Virtual de Salud Pública. OPS. Disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/respuesta-multiamenaza-planeamiento-hospitalario-emergencias

Curso: Curso virtual de evaluación de establecimientos de salud a través del índice de seguridad hospitalaria (ISHv2). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. Disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/evaluacion-de-establecimientos-de-salud

Curso: Gestión de salud pública de los incidentes químicos. Prevención, planificación y preparación, detección y alerta, respuesta y recuperación. Disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/salud-incidentes-quimicos

Contacto

Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED)
(24/7 los 365 días del año)
Teléfonos:
55 52 62 53 68 (directo)
55 52 38 27 00 (conmutador), Extensiones: 19081, 19083, 10315, 19832 y 19831
55 80 03 58 24 (WhatsApp)
Sitio web: https://cvoed.imss.gob.mx
Correo electrónico: cvoed.coord@imss.gob.mx

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)
55 5095 3200 línea nacional para reportes relacionados con fuentes radiactivas robadas o emergencias radiológicas.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
55 11 03 60 00 ext. 72034

Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil / Sistema Nacional de Protección Civil (CENACOM), 24 horas 365 días del año
51 28 00 00 ext. 36422 y 36428